

DIGITAL CONSULTORIA

PRIMEIROS SOCORROS

Prevenção, resposta inicial e suporte à vida até a chegada do atendimento especializado

APOSTILA PROFISSIONAL DE FORMAÇÃO

Digital Consultoria & Serviços Técnicos LTDA
Edição 2026

APRESENTAÇÃO

Esta apostila apresenta fundamentos e condutas iniciais de primeiros socorros para ambientes de trabalho, espaços educacionais e situações cotidianas. O objetivo é orientar a proteção da cena, o acionamento correto do socorro, a avaliação inicial e medidas simples capazes de evitar agravamentos até a chegada de profissionais habilitados.

LIMITES DE ATUAÇÃO

Primeiros socorros não substituem atendimento médico, não autorizam procedimentos invasivos e não habilitam o participante a prescrever medicamentos. Em qualquer dúvida, acione o SAMU 192 ou o serviço de emergência local e siga as orientações do regulador.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

- Reconhecer riscos antes de se aproximar da vítima.
- Acionar corretamente os serviços de emergência.
- Aplicar uma avaliação inicial organizada e segura.
- Reconhecer parada cardiorrespiratória, engasgo, hemorragias e outras urgências.
- Evitar condutas populares que podem causar danos.
- Organizar recursos, registros e planos de resposta no ambiente de trabalho.

PÚBLICO-ALVO

Trabalhadores, líderes, brigadistas, profissionais de segurança, educadores e demais pessoas que necessitem de conhecimentos introdutórios. Treinamento prático supervisionado é indispensável para o desenvolvimento de habilidades.

SUMÁRIO

1. Fundamentos dos primeiros socorros
2. Segurança da cena e biossegurança
3. Acionamento do socorro
4. Avaliação inicial da vítima
5. Parada cardiorrespiratória e RCP
6. Desfibrilador externo automático
7. Engasgo
8. Hemorragias e choque
9. Ferimentos e amputações
10. Fraturas, entorses e luxações
11. Traumas de cabeça, coluna e tórax
12. Queimaduras
13. Choque elétrico
14. Desmaio e alterações de consciência
15. Crise convulsiva
16. Infarto, dor no peito e AVC
17. Intoxicações e envenenamentos
18. Acidentes com animais peçonhentos
19. Emergências térmicas
20. Afogamento
21. Emergências em crianças e gestantes
22. Transporte e movimentação
23. Kit e organização de primeiros socorros
24. Plano de emergência no trabalho
25. Estudos de caso
26. Checklists e formulários
27. Glossário e referências

1. FUNDAMENTOS DOS PRIMEIROS SOCORROS

1.1 Conceito

Primeiros socorros são cuidados imediatos, temporários e seguros prestados a uma pessoa que sofreu mal súbito ou acidente, com a finalidade de preservar a vida, impedir agravamentos e favorecer a recuperação até a chegada do atendimento especializado.

1.2 Princípios essenciais

A atuação deve seguir três prioridades: proteger, alertar e socorrer. O socorrista leigo deve manter a calma, agir dentro de seus limites, evitar improvisos perigosos e respeitar a privacidade e a dignidade da vítima.

1.3 Consentimento e comunicação

Quando a vítima estiver consciente, apresente-se, explique o que pretende fazer e peça autorização. Em risco imediato e incapacidade de resposta, a ajuda pode ser iniciada visando proteger a vida. Fale de modo calmo, direto e sem prometer resultados.

2. SEGURANÇA DA CENA E BIOSSEGURANÇA

2.1 Avaliação do ambiente

Antes de tocar na vítima, observe trânsito, eletricidade, fogo, fumaça, produtos químicos, estruturas instáveis, violência, máquinas em movimento e outros perigos. Uma segunda vítima aumenta a gravidade da ocorrência.

2.2 Proteção do socorrista

Use luvas descartáveis sempre que houver sangue ou fluidos corporais. Quando houver risco de respingos, use proteção ocular e máscara. Higienize as mãos antes e após o atendimento e descarte materiais contaminados de forma segura.

2.3 Isolamento e controle

Interrompa a fonte de energia, bloqueie máquinas quando for possível e seguro, sinalize o local e mantenha curiosos afastados. Não entre em ambientes com fumaça, gases ou risco químico sem equipe e equipamento apropriados.

3. ACIONAMENTO DO SOCORRO

3.1 Números úteis

SAMU: 192. Corpo de Bombeiros: 193. Polícia Militar: 190. Informe o endereço completo, ponto de referência, telefone de retorno, quantidade de vítimas, riscos presentes e estado aparente da vítima.

3.2 Comunicação eficiente

Não desligue até que o atendente autorize. Coloque o telefone no viva-voz quando precisar continuar ajudando. Designe alguém para receber a ambulância e liberar o acesso.

3.3 Informações para a equipe

Relate o que aconteceu, horário aproximado, alterações observadas, medidas realizadas, doenças conhecidas e medicamentos informados pela vítima ou familiares.

Informação	Exemplo
Local	Rua, número, bairro, ponto de referência
Ocorrência	Queda, choque elétrico, dor no peito, queimadura
Vítimas	Quantidade, idade aproximada e estado
Riscos	Fogo, energia, produtos, trânsito
Contato	Nome e telefone de retorno

4. AVALIAÇÃO INICIAL DA VÍTIMA

4.1 Responsividade

Aproxime-se pela frente, toque suavemente nos ombros e pergunte em voz alta se a pessoa está bem. Observe movimentos, fala e reação.

4.2 Respiração

Se não houver resposta, verifique se a vítima respira normalmente. Respiração ausente ou apenas gasping exige acionamento imediato do socorro e início de RCP.

4.3 Avaliação rápida

Procure sangramento intenso, deformidades, queimaduras, sinais de choque e outras ameaças imediatas. Evite movimentar a vítima sem necessidade, principalmente quando houver suspeita de trauma.

SEQUÊNCIA PRÁTICA

Cena segura -> verificar resposta -> pedir ajuda -> avaliar respiração -> controlar sangramento grave -> manter vigilância até o socorro.

5. PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA E RCP

5.1 Reconhecimento

Suspeite de parada cardiorrespiratória quando a pessoa não responde e não respira normalmente. Chame ajuda, acione o 192 e solicite um DEA.

5.2 Compressões torácicas

Coloque a vítima de costas em superfície firme. Posicione as mãos no centro do tórax, mantenha os braços estendidos e realize compressões fortes e rápidas, permitindo retorno completo do tórax e reduzindo interrupções.

5.3 Continuidade

Continue até a chegada do socorro, recuperação de sinais de vida, exaustão física ou surgimento de risco para a cena. Revezar o socorrista aproximadamente a cada dois minutos ajuda a manter a qualidade.

TREINAMENTO PRÁTICO OBRIGATÓRIO

A posição das mãos, profundidade, frequência, ventilação e adaptações por faixa etária devem ser praticadas com instrutor e manequim. A apostila não substitui a prática.

6. DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO - DEA

6.1 Finalidade

O DEA analisa o ritmo cardíaco e orienta, por comandos de voz, se um choque é indicado. Ligue o aparelho assim que estiver disponível.

6.2 Uso seguro

Exponha e seque o tórax, coloque as pás conforme os desenhos, conecte o cabo quando necessário e não toque na vítima durante análise ou choque. Retome imediatamente as compressões quando o aparelho orientar.

6.3 Cuidados especiais

Afastede adesivos medicamentosos da área das pás, evite contato com água e mantenha distância de fontes de oxigênio livre durante o choque. Em crianças, use pás pediátricas quando disponíveis e siga o fabricante.

7. ENGASGO

7.1 Obstrução leve

Se a pessoa tosse e fala, incentive a tosse e observe. Não faça manobras desnecessárias.

7.2 Obstrução grave

Se não consegue falar, respirar ou tossir de forma eficaz, acione ajuda e aplique as manobras ensinadas em treinamento prático, adaptadas à idade, condição corporal e gravidez.

7.3 Perda de consciência

Se a vítima ficar inconsciente, coloque-a cuidadosamente no chão, acione o socorro e inicie RCP. Não faça varredura cega com os dedos; retire apenas objeto claramente visível e acessível.

8. HEMORRAGIAS E CHOQUE

8.1 Controle do sangramento

Faça pressão direta firme sobre o ferimento com gaze ou pano limpo. Se o material encharcar, adicione novas camadas sem retirar a primeira. Sangramento intenso exige atendimento imediato.

8.2 Choque

Sinais possíveis incluem pele fria e pálida, suor, fraqueza, ansiedade, sede, pulso rápido e alteração da consciência. Mantenha a vítima deitada, aquecida e sob observação. Não ofereça alimentos, bebidas ou medicamentos.

8.3 Torniquete

O uso de torniquete deve seguir protocolo e treinamento específico para hemorragia de extremidade com risco de morte. Registre o horário e não afrouxe após aplicado, salvo orientação profissional.

Sinal	Interpretação/ação
Sangue em jato ou poça crescente	Emergência; pressão direta e acionamento
Pele fria e pálida	Possível choque
Sonolência ou confusão	Risco de agravamento
Curativo encharcado	Adicionar camadas; não remover a primeira

9. FERIMENTOS E AMPUTAÇÕES

9.1 Feridas superficiais

Lave as mãos, use luvas, irrigue ferimentos pequenos com água limpa e proteja com curativo. Procure avaliação quando houver sujeira profunda, mordida, objeto perfurante, sinais de infecção ou vacinação antitetânica incerta.

9.2 Objetos encravados

Não retire objetos grandes ou profundamente encravados. Estabilize ao redor com curativos e aguarde o serviço especializado.

9.3 Parte amputada

Controle o sangramento. Envolver a parte amputada em gaze limpa levemente umedecida, coloque em saco plástico fechado e mantenha esse saco resfriado em outro recipiente com gelo e água, sem contato direto com o gelo.

10. FRATURAS, ENTORSES E LUXAÇÕES

10.1 Reconhecimento

Dor, inchaço, deformidade, incapacidade de movimento e crepitação podem indicar lesão musculoesquelética.

10.2 Conduta

Mantenha a parte na posição encontrada, retire adornos próximos se houver inchaço e imobilize apenas se houver treinamento e necessidade. Não tente alinhar ossos ou recolocar articulações.

10.3 Lesão exposta

Cubra com curativo limpo sem pressionar fragmentos ósseos. Controle sangramento ao redor e acione emergência.

11. TRAUMAS DE CABEÇA, COLUNA E TÓRAX

11.1 Suspeita de coluna

Quedas, colisões, mergulho em água rasa e impactos fortes podem causar lesões cervicais. Oriente a vítima a não se mover e estabilize manualmente a cabeça apenas se necessário e treinado.

11.2 Sinais de alarme

Vômitos repetidos, sonolência crescente, confusão, convulsão, sangramento ou líquido por nariz/ouvidos, fraqueza e pupilas diferentes exigem avaliação urgente.

11.3 Trauma torácico

Dificuldade para respirar, dor intensa, ferida aberta no tórax ou coloração azulada são emergências. Mantenha a vítima em posição confortável, não ofereça líquidos e acione o 192.

12. QUEIMADURAS

12.1 Interromper o agente

Afaste a vítima da fonte com segurança, retire roupas e adornos que não estejam aderidos e resfrie a área com água corrente fresca. Não use gelo, pasta de dente, manteiga, pó de café ou receitas caseiras.

12.2 Proteção

Cubra com pano limpo ou curativo não aderente. Não rompa bolhas. Queimaduras extensas, profundas, elétricas, químicas ou em face, mãos, pés, genitais e vias aéreas necessitam avaliação urgente.

12.3 Queimadura química

Proteja-se, retire o produto seco antes de irrigar quando apropriado e lave com grande quantidade de água, salvo orientação específica da ficha de segurança do produto.

Faça	Não faça
Resfrie com água corrente fresca	Não aplique gelo diretamente
Retire adornos não aderidos	Não arranque roupa grudada
Cubra com material limpo	Não estoure bolhas
Procure atendimento nas queimaduras graves	Não use receitas caseiras

13. CHOQUE ELÉTRICO

13.1 Desligamento

Não toque na vítima enquanto ela estiver em contato com a corrente. Desligue a fonte de energia ou solicite equipe competente. Alta tensão exige isolamento e equipe especializada.

13.2 Avaliação

Após tornar a cena segura, verifique responsividade e respiração. Inicie RCP e use DEA quando indicado.

13.3 Lesões ocultas

Mesmo com pequenas marcas externas, pode haver arritmia, queimadura profunda e trauma por queda. Acione atendimento para avaliação.

14. DESMAIO E ALTERAÇÕES DE CONSCIÊNCIA

14.1 Desmaio

Deite a pessoa, afrouxe roupas apertadas, mantenha ventilação e observe. Não ofereça líquidos enquanto estiver sonolenta. Se não recuperar rapidamente ou houver dor no peito, falta de ar, trauma ou gravidez, acione emergência.

14.2 Posição lateral de segurança

Pessoa inconsciente que respira normalmente e não apresenta suspeita importante de trauma pode ser colocada de lado para manter a via aérea, com vigilância contínua.

14.3 Hipoglicemia suspeita

Em pessoa consciente e capaz de engolir, siga o plano individual já conhecido e busque orientação. Nunca dê comida ou bebida a pessoa inconsciente ou com dificuldade para engolir.

15. CRISE CONVULSIVA

15.1 Durante a crise

Proteja a cabeça, afaste objetos perigosos, marque o tempo e não contenha os movimentos. Não coloque nada na boca.

15.2 Após a crise

Quando os movimentos cessarem, verifique a respiração, coloque de lado se apropriado e permaneça até recuperação.

15.3 Acionamento

Chame o 192 se for a primeira crise conhecida, durar mais que alguns minutos, repetir sem recuperação, ocorrer na água, houver gravidez, trauma, dificuldade respiratória ou demora para despertar.

16. INFARTO, DOR NO PEITO E AVC

16.1 Dor torácica

Dor, pressão ou aperto no peito, suor frio, náusea, falta de ar e desconforto irradiado podem indicar infarto. Interrompa esforço, mantenha repouso e acione 192.

16.2 Sinais de AVC

Use o reconhecimento rápido: sorriso torto, fraqueza em um braço e fala alterada. Registre o horário em que a pessoa foi vista bem pela última vez e chame imediatamente o SAMU.

16.3 Medicamentos

Não ofereça medicamentos por conta própria. Auxilie apenas na utilização de medicação prescrita para aquela pessoa quando houver orientação do serviço de emergência.

TEMPO É DECISIVO

Na suspeita de infarto ou AVC, não espere os sintomas melhorarem e não leve a vítima dirigindo de forma insegura. Acione o SAMU 192.

17. INTOXICAÇÕES E ENVENENAMENTOS

17.1 Segurança

Evite contato com o agente, ventile o local quando seguro e preserve embalagens, rótulos ou fotos do produto.

17.2 Conduta

Não provoque vômito e não ofereça leite, álcool ou neutralizantes caseiros. Acione o 192 e o centro de informação toxicológica indicado para sua região.

17.3 Inalação

Não entre em espaço contaminado sem proteção respiratória adequada. Remova a vítima apenas quando a cena estiver segura e por pessoal habilitado.

18. ACIDENTES COM ANIMAIS PEÇONHENTOS

18.1 Conduta geral

Afastar-se do animal, mantenha a pessoa calma, lave o local com água e sabão e procure serviço de saúde rapidamente.

18.2 O que não fazer

Não faça torniquete, cortes, sucção, aplicação de substâncias ou gelo direto. Não tente capturar o animal colocando outras pessoas em risco.

18.3 Identificação

Uma foto à distância, quando segura, pode ajudar. Informe horário, local do acidente e evolução dos sintomas.

19. EMERGÊNCIAS TÉRMICAS

19.1 Exaustão pelo calor

Leve para local fresco, retire excesso de roupa, resfrie com panos úmidos e ofereça pequenos goles de água somente se a pessoa estiver totalmente consciente e sem náuseas importantes.

19.2 Golpe de calor

Confusão, desmaio, convulsão e pele muito quente indicam emergência. Acione 192 e inicie resfriamento rápido enquanto aguarda.

19.3 Hipotermia

Retire roupas molhadas, proteja do vento, aqueça gradualmente e manuseie com cuidado. Não aplique calor intenso diretamente na pele.

20. AFOGAMENTO

20.1 Resgate seguro

Não entre na água sem treinamento. Prefira alcançar, lançar objeto flutuante ou solicitar resgate especializado.

20.2 Após retirar da água

Avalie responsividade e respiração, acione o 192 e inicie RCP quando necessário. Use DEA assim que possível, secando o tórax.

20.3 Cuidados

Não tente retirar água dos pulmões comprimindo o abdômen. Suspeite de trauma cervical em mergulhos e impactos.

21. CRIANÇAS, BEBÊS E GESTANTES

21.1 Diferenças

Técnicas de RCP, desobstrução e uso do DEA variam conforme idade e tamanho. A prática deve ser feita em manequins com instrutor qualificado.

21.2 Gestante

Em urgências, acione cedo o serviço médico. Em engasgo, as manobras são adaptadas. Em trauma, preserve a segurança e evite movimentações desnecessárias.

21.3 Proteção infantil

Acidentes domésticos, intoxicações, queimaduras, quedas e engasgos são preveníveis com supervisão, armazenamento seguro e barreiras físicas.

22. TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO

22.1 Regra geral

Não movimente a vítima, exceto quando permanecer no local represente perigo maior, como fogo, desabamento, eletricidade ou trânsito.

22.2 Remoção de emergência

Use técnicas simples apenas quando indispensável e respeite sua capacidade física. Solicite apoio para evitar quedas e lesões.

22.3 Capacete

Em acidentes com motociclista, não retire o capacete sem necessidade imediata de acesso à via aérea e sem treinamento adequado.

23. KIT E ORGANIZAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS

23.1 Conteúdo básico

Luvas descartáveis, máscaras, proteção ocular, gases, curativos, ataduras, fita, tesoura de ponta romba, manta térmica, solução para higiene das mãos, saco para descarte e ficha de registro.

23.2 Gestão

O conteúdo deve considerar os riscos do local, quantidade de pessoas, distância do atendimento e requisitos internos. Defina responsável, inspeção periódica, reposição e controle de validade.

23.3 Medicamentos

Kits institucionais não devem conter medicamentos para administração indiscriminada. A empresa deve seguir orientação médica e legal aplicável.

24. PLANO DE EMERGÊNCIA NO TRABALHO

24.1 Preparação

Mapeie cenários, rotas de acesso, contatos, responsáveis, pontos de encontro, recursos e comunicação. Integre o plano ao PGR, à brigada e aos procedimentos operacionais.

24.2 Simulados

Realize exercícios periódicos, com objetivos definidos, observadores e análise de desempenho. Registre oportunidades e implemente melhorias.

24.3 Pós-ocorrência

Preserve informações, registre horários e ações, ofereça apoio às pessoas envolvidas e conduza análise sem culpabilização, buscando causas e prevenção.

25. ESTUDOS DE CASO

Caso 1 - Queda em escada

Um trabalhador cai de aproximadamente dois metros, permanece consciente e refere dor cervical. Conduta esperada: interromper atividades, isolar a área, orientar a não se mover, acionar o socorro, observar respiração e consciência e não sentá-lo ou colocá-lo em veículo particular sem avaliação.

Caso 2 - Choque elétrico

Uma pessoa permanece em contato com equipamento energizado. Conduta esperada: não tocar, desligar a energia por meio seguro, acionar emergência, avaliar resposta e respiração e iniciar RCP/DEA se indicado.

Caso 3 - Dor no peito

Trabalhador apresenta aperto no peito, suor frio e náusea. Conduta esperada: interromper esforço, manter repouso, acionar 192, observar respiração e preparar acesso para a equipe.

Caso 4 - Produto químico nos olhos

Funcionário sofre respingo químico. Conduta esperada: usar proteção, conduzir ao lava-olhos, irrigar conforme ficha de segurança e orientação de emergência, retirar lentes quando possível sem atraso e encaminhar para avaliação.

DISCUSSÃO EM GRUPO

Em cada caso, identifique: riscos da cena, prioridade, quem aciona o socorro, materiais necessários, informações a registrar e erros que devem ser evitados.

26. CHECKLISTS E FORMULÁRIOS

26.1 Checklist de prontidão

Item	Conforme	Ação necessária
Contatos de emergência visíveis	[]	
Acesso para ambulância desobstruído	[]	
Kit completo e dentro da validade	[]	
DEA sinalizado e inspecionado	[]	
Equipe treinada e escala atualizada	[]	
Simulado realizado	[]	
Fichas de produtos químicos disponíveis	[]	

26.2 Registro de atendimento

Campo	Registro
Data e horário	
Local	
Nome da vítima	
Descrição da ocorrência	
Condição inicial	
Medidas realizadas	
Serviço acionado e horário	
Encaminhamento	
Responsável pelo registro	

26.3 Verificação mensal do kit

Material	Quantidade mínima	Validade/estado	Reposição
Luvas	Conforme risco		
Gazes e curativos	Conforme risco		
Ataduras e fita	Conforme risco		
Máscaras e proteção ocular	Conforme risco		
Manta térmica	1 ou mais		
Tesoura de ponta romba	1		
Sacos para descarte	Conforme risco		

27. GLOSSÁRIO

Termo	Definição
DEA	Desfibrilador externo automático.
Emergência	Situação com risco imediato de morte ou dano grave.
Gasping	Respiração agônica, irregular e ineficaz, possível sinal de parada.
Hemorragia	Perda de sangue por lesão vascular.
RCP	Ressuscitação cardiopulmonar.
SAMU	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, acionado pelo 192.
Socorrista leigo	Pessoa sem formação profissional em saúde que presta ajuda inicial dentro de seus limites.
Via aérea	Caminho percorrido pelo ar até os pulmões.

REFERÊNCIAS E BASES DE CONSULTA

- BRASIL. Ministério da Saúde. SAMU 192 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Portal Gov.br.
- BRASIL. Ministério da Saúde; CONASEMS; UFRGS. Noções de primeiros socorros. Brasília, 2025.
- AMERICAN HEART ASSOCIATION. 2025 Guidelines for CPR and Emergency Cardiovascular Care: Adult Basic Life Support.
- Normas e procedimentos internos de segurança e emergência aplicáveis ao estabelecimento.
- Fichas com Dados de Segurança (FDS) dos produtos químicos presentes no ambiente.

ATUALIZAÇÃO DO MATERIAL

Protocolos de primeiros socorros podem ser atualizados. Antes de ministrar o curso, confirme as recomendações oficiais vigentes e adapte o conteúdo aos riscos reais do público e do local.

ENCERRAMENTO

A atuação segura começa pela prevenção, passa pelo reconhecimento rápido e termina com a entrega organizada da vítima à equipe especializada. Conhecimento, prática supervisionada, calma e respeito aos limites de atuação são os pilares de um bom primeiro atendimento.